

Rinitis aguda y crónica (alérgica y no alérgica)

1. Introducción y relevancia clínica

La **rinitis** se define como la **inflamación de la mucosa nasal**, caracterizada clínicamente por **obstrucción nasal, rinorrea, estornudos y prurito**.

Se clasifica según su evolución en **aguda (<4 semanas)** y **crónica (>12 semanas)**, y según su causa en **alérgica** y **no alérgica** (infecciosa, irritativa, vasomotora, medicamentosa, etc.).

Relevancia clínica

- Es una de las patologías respiratorias **más frecuentes en la atención primaria**.
 - La **rinitis alérgica** afecta cerca del **20–25% de la población chilena**, y es un factor de riesgo para **asma bronquial y sinusitis crónica**.
 - Las **rinitis no alérgicas** son causas comunes de obstrucción nasal persistente y de abuso de vasoconstrictores tópicos.
 - Su manejo adecuado **mejora la calidad de vida** y previene complicaciones respiratorias.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía y fisiología nasal

La mucosa nasal está formada por epitelio respiratorio ciliado con glándulas secretoras, vasos capacitantes y células inmunológicas.

Cumple funciones de **filtración, humidificación, defensa inmunológica y regulación del flujo aéreo**.

El tono vascular nasal está regulado por:

- **Sistema nervioso simpático:** vasoconstrictor.
 - **Sistema parasimpático:** vasodilatador y secretor.
-

2.2 Rinitis aguda (infecciosa o viral)

- Causa más frecuente: **virus respiratorios** (rinovirus, coronavirus, influenza, parainfluenza, adenovirus).
 - Produce inflamación transitoria de la mucosa, con **hipersecreción mucosa y edema**.
 - Suele durar menos de 10 días.
 - En un porcentaje menor, puede complicarse con **sinusitis bacteriana**.
-

2.3 Rinitis alérgica (RA)

Proceso **inmunológico mediado por IgE**, desencadenado por exposición a **alérgenos ambientales** (ácaros, pólenes, epitelios de animales, hongos, etc.).

Fases fisiopatológicas

1. **Sensibilización:** exposición inicial → producción de IgE específica unida a mastocitos.
2. **Fase temprana (minutos):** reexposición → liberación de histamina, prostaglandinas y leucotrienos → prurito, estornudos y rinorrea.
3. **Fase tardía (horas):** infiltración de eosinófilos y linfocitos → inflamación persistente y congestión nasal.

Clasificación ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma)

- **Intermitente:** <4 días/semana o <4 semanas.
 - **Persistente:** >4 días/semana y >4 semanas.
 - **Leve / Moderada-severa:** según impacto en sueño, actividades y rendimiento.
-

2.4 Rinitis no alérgica (RNA)

Incluye múltiples mecanismos **no mediados por IgE**:

- **Vasomotora:** desequilibrio autonómico (respuesta exagerada al frío, humo, perfumes).
 - **Medicamentosa:** uso prolongado (>5 días) de vasoconstrictores tópicos → efecto rebote.
 - **Hormonal:** embarazo, hipotiroidismo.
 - **Ocupacional:** exposición a irritantes químicos o polvo.
 - **Atrófica:** pérdida del epitelio ciliado, costras y mal olor.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas cardinales

Síntoma	Descripción
Obstrucción nasal	Variable, suele ser bilateral.
Rinorrea	Serosa en alérgica o viral; mucopurulenta en infecciosa bacteriana.
Estornudos	Frecuentes en rinitis alérgica.
Prurito nasal y ocular	Característico de RA.
Hiposmia o anosmia	Común en rinitis crónica o poliposis.
Síntomas asociados	Tos irritativa, conjuntivitis alérgica, cefalea facial.

3.2 Signos al examen físico

Hallazgo	Significado
Mucosa pálida, edematosa, con moco claro	Rinitis alérgica.
Mucosa hiperémica, congestiva	Rinitis infecciosa o vasomotora.
Cornetes hipertrofiados	Rinitis crónica.
Costras o secreción purulenta	Infección bacteriana o atrofia mucosa.
En niños, inspeccionar cavidad nasal para descartar cuerpo extraño unilateral con rinorrea fétida.	

3.3 Diagnóstico diferencial

Entidad	Características distintivas
Sinusitis aguda	Dolor facial, fiebre, rinorrea purulenta persistente >10 días.
Poliposis nasal	Obstrucción progresiva, hiposmia, antecedentes de asma.
Desviación septal	Obstrucción unilateral, sin rinorrea.
Rinitis medicamentosa	Empeora tras uso prolongado de descongestionantes.
Rinitis vasomotora	Desencadenada por olores, cambios térmicos o estrés.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

En la mayoría de los casos, el diagnóstico es **clínico** basado en la anamnesis y examen físico.

4.2 Estudios complementarios

Examen	Utilidad
Pruebas cutáneas de alergia (Prick test)	Identificación de alérgenos específicos.
IgE sérica total o específica (RAST)	Alternativa en pacientes que no pueden suspender antihistamínicos.
Endoscopía nasal	En rinitis crónica o refractaria; permite evaluar cornetes, pólipos, secreciones.
TAC de senos paranasales	Si se sospecha sinusitis crónica o poliposis asociada.
Cultivo nasal o frotis bacteriano	Solo en rinitis purulenta o resistente a tratamiento.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento depende de la causa y severidad, orientado a **control de síntomas, reducción de la inflamación y prevención de complicaciones.**

5.1 Rinitis aguda (viral o infecciosa)

Medida	Detalle
Tratamiento sintomático	Paracetamol o AINEs para fiebre/dolor.
Lavado nasal con solución salina	Alivia congestión y mejora aclaramiento mucociliar.
Vasoconstrictores tópicos (oximetazolina, nafazolina)	Solo 3–5 días para evitar rinitis medicamentosa.
Antibióticos	Solo si hay evidencia de infección bacteriana secundaria o sinusitis (amoxicilina/ácido clavulánico 875/125 mg c/12h por 7–10 días).

5.2 Rinitis alérgica (RA)

A. Medidas generales

- Evitar alérgenos (ácaros, polvo, mascotas).
- Funda antiácaros, lavado frecuente de sábanas.
- Cierre de ventanas durante alta polinización.

B. Tratamiento farmacológico

Fármaco	Acción	Ejemplo / Dosis
Antihistamínicos orales (2ª generación)	Bloquean H1, controlan estornudos y prurito	Loratadina 10 mg/día, cetirizina 10 mg/día
Corticoides nasales tópicos (1ª línea)	Potente efecto antiinflamatorio local	Mometasona, fluticasona, budesonida

Descongestionantes orales (pseudoefedrina)	Alivian congestión, uso breve	Evitar en HTA o cardiopatías
Antileucotrienos (montelukast)	Útil en RA asociada a asma	10 mg/día
Inmunoterapia específica (vacunas)	En RA grave refractaria o multialérgica	Bajo control alergológico

5.3 Rinitis no alérgica

Tipo	Manejo principal
Vasomotora	Evitar desencadenantes + corticoides nasales.
Medicamentosos	Suspender vasoconstrictor, usar corticoide nasal + antihistamínico oral.
Hormonal	Medidas sintomáticas, se resuelve tras parto o corrección endocrina.
Atrófica	Lavados salinos, pomadas nasales lubricantes, antibióticos tópicos si costras infectadas.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Sinusitis aguda o crónica	Por obstrucción de ostium y drenaje mucoso.

Otitis media serosa En niños, por disfunción tubárica secundaria.

Poliposis nasal Inflamación crónica persistente.

Rinitis medicamentosa Por abuso de descongestionantes tópicos.

Asma alérgica Frecuente comorbilidad (vía aérea unificada).

Pronóstico:

Excelente con manejo adecuado.

En rinitis alérgica, los síntomas pueden controlarse eficazmente, pero rara vez desaparecen por completo.

La inmunoterapia puede inducir remisión prolongada en casos seleccionados.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Rinitis alérgica = síntomas bilaterales + prurito + antecedentes personales o familiares atópicos.**
 2. **Rinorrea purulenta prolongada o fiebre → sospechar sinusitis bacteriana.**
 3. **Uso crónico de vasoconstrictores = rinitis medicamentosa.**
 4. **Corticoides nasales son el tratamiento más eficaz** para RA moderada a severa.
 5. **Pruebas cutáneas positivas** orientan a inmunoterapia específica.
 6. **Rinitis y asma alérgica** deben tratarse en conjunto (concepto de vía aérea unificada).
-

Errores comunes

- Prescribir antihistamínicos sedantes de primera generación.
 - Mantener vasoconstrictores tópicos más de 5 días.
 - No tratar la inflamación subyacente con corticoide nasal.
 - No identificar comorbilidades como asma o poliposis.
 - Confundir RA con sinusitis crónica por congestión persistente.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **rinitis** es una inflamación de la mucosa nasal, de origen **viral, alérgico o no alérgico**.
2. La **rinitis alérgica** es mediada por IgE y tiene fuerte asociación con **asma bronquial**.
3. El **diagnóstico es clínico**, apoyado por pruebas cutáneas o IgE específica.
4. El **tratamiento de elección** en RA es el **corticoide nasal**, complementado con antihistamínicos.
5. La **rinitis medicamentosa** se previene limitando los vasoconstrictores tópicos a 3–5 días.
6. La **inmunoterapia específica** es una opción eficaz en casos persistentes y documentados.
7. Con manejo adecuado, el pronóstico es **excelente y mejora significativamente la calidad de vida**.